Introducción a la Unidad 1

Vea este video en la versión online de la clase
Unidad 1 "Evaluación Primaria y Secundaria". Elaborada por Catalina Baeza, Urgencióloga Clínica UC San Carlos de Apoquindo.

Objetivo de la Unidad

- Identificar herramientas para la evaluación y el manejo inicial del paciente grave que consulta al servicio de urgencia.

Importancia de la Evaluación Primaria en Urgencias

La primera aproximación en urgencia al paciente con patología aguda indiferenciada se denomina Evaluación Primaria, la que permitirá la pesquisa oportuna y tratamiento de pacientes con riesgo vital, tema que profundizaremos en este artículo.

Los Servicios de Urgencia son centros atención de alta complejidad médica, sin restricción de entrada de usuarios, ingresan pacientes que presentan motivos de consulta indiferenciados y en múltiples etapas de la enfermedad.

En una urgencia se presentan pacientes que cursan desde la etapa inicial de una enfermedad hasta presentaciones avanzadas de la misma, con riesgo vital.

Una proporción importante de las consultas médicas, y de los contactos de las personas con el sistema de salud, se realiza en el servicio de urgencia. De acuerdo con las cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) en el año 2015 en Atención Primaria (APS) se atendieron aproximadamente 16 millones de pacientes mientras que en los servicios de urgencias esta cifra ascendió a 19 millones de pacientes, siendo además la urgencia la principal puerta de entrada al servicio hospitalario público en el país.

Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención (por habitantes)	
Total	42.814.701
Atención Primaria	16.284.424
Atención especialidades	7.377.415
Atención Urgencia	19.152.862
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	1.360.567
Intervenciones quirúrgicas (sector público)	1.009.186
Atención de hospitalización (sector público y privado)	
Camas de Hospitalización	34.674
Número de egresos hospitalarios	1.671.054

Fuente: Departamento de estadísticas e información en salud (DEIS), Ministerio de Salud.

Este escenario no difiere mucho de lo que ocurre en el sistema privado de salud en el que el número de consultas médicas ambulatorias es similar al número de atenciones de urgencia, alcanzando cerca de 3.000.000 durante el 2015.

Por lo tanto, la mayoría de los pacientes que requieren de una atención de salud consultará al servicio de urgencia ya sea público como privado[1].

La medicina de urgencia es uno de los escenarios laborales más difíciles que podemos encontrar en la medicina, debido al gran volumen de pacientes y su alta complejidad. Es así como, el médico debe hacer varias cosas en paralelo: clasificar riesgos (alto riesgo y bajo riesgo), diagnosticar y tratar al mismo tiempo, atendiendo a varios pacientes a la vez. A esto se suma el cansancio producto de largas jornadas de trabajo (las urgencias funcionan las 24 horas) y turnos en horarios inhabituales.

Categorización de pacientes que ingresan a la Urgencia

La “Urgencia” no es definida por el personal de salud, sino por el paciente o sus acompañantes. De hecho, el 70% de los pacientes que consultan al servicio de urgencia estiman que su problema de salud debe ser resuelto en las próximas 2 horas, lo que ha producido un sobrepoblamiento a nivel mundial en estos servicios.

Dando respuesta a esta situación, se han generado sistemas de clasificación y priorización de la atención de pacientes conocidos como *triage*, que se originaron en situaciones de guerra y han sido adaptados a la vida civil para establecer un orden de atención según gravedad y estimación de uso de recursos sanitarios en los servicios de urgencia[2].

De esta forma, en los servicios de urgencia se ha intentado educar a los pacientes con la siguiente imagen disponible en las salas de espera, la que muestra esta categorización de grado de urgencia:

Hipervínculo Externo: *Categorización de urgencias.* VER

Patologías tiempo dependiente

Desde la admisión del paciente a la unidad de emergencia, la evolución y el pronóstico de los enfermos estarán determinados por la pesquisa y manejo oportunos de aquellas condiciones que amenazan su vida o funcionalidad[3].

Existe un concepto muy importante para el personal de salud que trabaja en la urgencia que es la patología tiempo dependiente, se refiere a esas enfermedades cuya evolución y su pronóstico están determinados por su pesquisa y manejo oportuno, lo que influirá tanto en la funcionalidad como en la mortalidad del paciente.

Ejemplos:
Un paciente con un accidente cerebrovascular identificado dentro de un tiempo determinado ("ventana terapéutica") podría acceder a tratamientos (por ejemplo: trombólisis) que eventualmente tendrán mejores resultados para su funcionalidad posterior.

El caso más evidente de la patología tiempo dependiente es el paro cardiorrespiratorio, donde depende del masaje cardíaco externo oportuno y de la desfibrilación eléctrica oportuna lograr la recuperación de la circulación espontánea y que el paciente viva.

Distintos estudios han planteado una disminución de la mortalidad si existe una reanimación precoz, por ejemplo, en situación de trauma o sepsis. Hasta un 33% de las muertes serían potencialmente evitables con intervención oportuna durante los primeros minutos de atención.

Lo que nos diferencia en medicina de urgencia

El ambiente en medicina de urgencia es distinto al resto de las especialidades, por lo tanto, es importante tener una manera de pensar distinta. Esto se logra con la evaluación primaria, en que se cambia la manera de enfrentar a los pacientes.

La evaluación primaria es:

La primera aproximación del médico de urgencia al paciente con patología aguda indiferenciada.

Un método rápido, estructurado y sistematizado para controlar en un ambiente en que todo es incontrolable.

Minimizar todo lo posible el error al tomar decisiones, en un ambiente adverso con poca información.

Identificar y priorizar pacientes con gravedad extrema o potencial gravedad.

La evaluación primaria nos permite saber qué medidas podemos implementar automáticamente para avanzar en el proceso de atención.

Nos referimos a **medidas de resucitación o reanimación**, intervenciones rápidas agresivas realizadas por el equipo de salud con el objetivo de hacer reversible la condición grave del paciente.

La evaluación primaria es dinámica, una evaluación alterada nos debe llevar a realizar una intervención que la contrarreste, luego debemos reevaluar el resultado de nuestra acción y nuevamente volver a objetivar el estado general de nuestro paciente.

Mientras un paciente esté en el servicio de Urgencia, la evaluación primaria se debe hacer automáticamente en la mente del médico hasta que el paciente salga de nuestro servicio de Urgencia.

Es importante trabajar la evaluación primaria con cada paciente como especialistas, ya sea que venga por una herida cortante, fiebre, cefalea, un infarto o en paro.

Vemos muchísimos pacientes y todos ellos pueden presentar algo grave o potencialmente grave, la evaluación primaria ordenada y sistemática nos ayudará a no subestimar signos vitales, motivos de consulta, a superar el cansancio y otras dificultades de nuestro trabajo.

Muchas veces durante la atención no se llegará al diagnóstico definitivo, pero sí deben descartarse aquellas patologías que conlleven riesgo de la vida o discapacidad.

En el siguiente artículo te invitamos a revisar cada una de las etapas que incluye la evaluación primaria.

Evaluación Primaria y Secundaria en Urgencias

En este artículo profundizaremos en cada una de las fases de la evaluación primaria para la reanimación del paciente indiferenciado en los servicios de urgencia, luego de la cual podremos hacer una evaluación secundaria.

Reanimación del paciente en los servicios de urgencia

Antecedentes históricos

En 1957 Peter Safar, médico austríaco, conocido como el “Padre de la Resucitación” formuló un algoritmo llamado el **ABC de la Resucitación** que resumía la evidencia de la época sobre la reanimación cardiopulmonar. Su idea era masificar estas acciones para salvar vidas en colegios, calles, etc., ya que gran porcentaje de los paros cardiorrespiratorios no suceden en un servicio de urgencia sino fuera del hospital.

El sistema ABC fue un éxito, siendo rápidamente aceptado y difundido. Es así como en 1973 fue declarado como el método estándar de reanimación cardiopulmonar por la American Heart Association[1].

Algo posterior fue creado el algoritmo ABCDE, formulado por cirujanos, con el objetivo que médicos poco expuestos al trauma tuvieran claridad mental al actuar con un paciente poli traumatizado. Este modelo fue introducido por James Styner y enseñado desde los años 70 por el American College of Surgeons a través de las guías ATLS.
Este algoritmo tiene como objetivo efectuar una rápida valoración del paciente traumatizado, cualquiera sea su edad, con el fin de identificar inmediatamente lesiones que amenacen su vida o funcionalidad.

El ABCDE del trauma, desde sus orígenes, ha sido una herramienta creada para facilitar que el médico, principalmente aquel con menos experiencia en manejo del trauma, se enfrente ordenada y sistemáticamente al paciente, sin desatender lesiones potencialmente fatales.

Los componentes del algoritmo del trauma son:

Como profesional de la salud tenemos que ir más allá, esta guía está hecha para ayudar a médicos poco expuestos y nosotros sí vamos a estar expuestos frecuentemente a pacientes graves. La evaluación primaria del médico de urgencia nos va a ayudar a objetivar nuestra impresión global del paciente que entra al box. Deberíamos hacerlo en todos los pacientes, con los poco complejos y los más complejos.

Ningún algoritmo va a poder reemplazar nunca el criterio clínico, pero es necesario encontrar algún mecanismo para formar el criterio clínico, como se grafica en el siguiente esquema:

Estos algoritmos son aplicados actualmente no sólo en el paciente traumatizado, si no que son extrapolados a toda situación de resucitación y a la evaluación inicial sistemática de todos los pacientes que consultan en el servicio de urgencia (Ml Velasco y cols. Rev. Chilena de Medicina Intensiva.2012).

En el siguiente video, la doctora Catalina Baeza explica la importancia de este algoritmo en la evaluación primaria.

Vea este video en la versión online de la clase

Evaluación Primaria

A continuación profundizaremos en la evaluación primaria, fase inicial del proceso diagnóstico.
La clave de la efectividad de la evaluación primaria está dada por su dinamismo y simpleza. Al mismo tiempo que el paciente va siendo interrogado y examinado, nuevos antecedentes son recopilados y las intervenciones terapéuticas van ocurriendo conforme los problemas son detectados.

- ¿Quién es?
- Aspecto general
- Motivo de consulta
- En resumen: ¿Cómo se ve este paciente?

Se propone un orden sistemático para realizar la primera aproximación diagnóstica, la que separaremos por letra solo por motivos didácticos, pero es importante considerar que de acuerdo a lo que se observa en el paciente, se puede alterar el orden de la evaluación, de hecho la evaluación integral de cada aspecto es más relevante que cada elemento por separado.

A: Vía aérea y columna cervical

En esta etapa se debe evaluar la permeabilidad evidente de la vía aérea buscando la presencia de **secreción, estridor, quemaduras o cuerpos extraños** y la capacidad del paciente de proteger su vía aérea. También se deben ver signos que anticipen un posible deterioro del paciente tales como compromiso de conciencia, lesiones en el cuello que puedan obstruir vía aérea, etc.

Aunque pueda parecer extraño, la columna cervical se incluye en la A, porque hay maniobras de reposicionamiento para proteger la vía aérea que, en el contexto de un paciente con trauma, pueden empeorar una lesión en la columna cervical y llevar a que el paciente quede con grave discapacidad funcional.

La protección de la columna cervical, en contexto de trauma o si el paciente está inconsciente y desconocemos si tuvo un traumatismo o no, se debe asegurar en este momento de la evaluación primaria con un collar cervical rígido ajustable hasta poder certificar que es seguro retirarlo.

Intervenciones en esta etapa:

- Posicionar vía aérea.
- Retiro cuerpo extraño, prótesis dentales, etc.
- Aspiración de secreciones.
- Intubación orotraqueal (con o sin secuencia rápida de intubación, manejando fármacos y dosis).
- Manejo quirúrgico vía aérea.
- Siempre con protección de columna cervical con collar rígido de sospechar trauma.

No es casual que en la evaluación primaria la vía aérea sea la primera, porque sin oxigenación y ventilación adecuada (A y B en conjunto) el resto de las medidas resultan inútiles.

B: Respiración

La etapa B (respiración) tiene mucha relación con la A, pero se enfoca más de la mecánica respiratoria del paciente y el examen global del proceso respiratorio. Inicialmente nos debemos fijar en si el paciente ventila o no y cómo respira el paciente, en su mecánica ventilatoria, si tiene un patrón de respiración abdominal o usa musculatura accesoria para respirar entre otras cosas. También es fundamental medir y registrar la frecuencia respiratoria del paciente, aunque no consulte por un motivo respiratorio, así como también su oximetría de pulso (SatO2).

Deben ser evaluadas todas las estructuras involucradas en el aparato respiratorio:

- Observar: Yugulares ingurgitadas, desviación de la tráquea, uso de musculatura accesoria, respiración paradojal, simetría del tórax, cianosis.
- Auscultar: Presencia y simetría del murmullo pulmonar, ruidos agregados (sibilancias, roncus, crépitos).
- Palpar: Enfisema subcutáneo y crépitos óseos.

Intervenciones en esta etapa:

- Oxigenoterapia.
- Nebulizaciones.
- Descompresión torácica con aguja gruesa.
- Pleurostomía (Drenaje pleural).

C: Circulación

La C es la etapa que mide la función cardiocirculatoria del paciente. Muchas veces será el primer aspecto en ser evaluado.

Se debe medir:

- Presión Arterial.
- Frecuencia Cardíaca.
- Perfusión distal (función circulatoria).
- Hemorragia evidente o signos indirectos.
- TACO (preguntar por anticoagulante).

Es importante objetivar estos números, nunca se debe dar de alta a un paciente con una presión cardíaca alterada sin explicarnos con certeza qué es lo que está pasando.

Es conocido el hecho de que muchos pacientes pueden encontrarse en shock o presentar hemorragias ocultas, manteniendo sus signos vitales normales, como es el caso de pacientes que toman medicamentos para patologías cardiovasculares, hipertensos, etc[2]. En estos casos, hay aspectos como la perfusión distal, enlentecimiento del llene capilar periférico o la diferencia de magnitud entre temperatura central y temperatura periférica que resultan más objetivas que los signos vitales.

Es importante también evaluar signos de hemorragia y preguntar por el uso de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios.

Intervenciones en esta etapa:

- Monitorización continua del paciente (monitorización cardíaca y oximetría de pulso).
- Instalación de VVP (Vía venosa periférica).
- Tomar ECG (electrocardiograma.)
- Volemización.
- Transfusión hemoderivados.
- Tratamiento farmacológico de arritmias o cardioversión eléctrica.
- Reversión de anticoagulación.
- Pericardiocentesis.
- Marcapaso externo.
- Involucrar al equipo de cirugía y traslado expedito a pabellón. Un rápido traslado a pabellón puede ser la intervención que mejore el pronóstico vital en algunos pacientes.

Nada de lo que se pueda hacer en las etapas siguientes (D,E) tendrá sentido si el paciente no logra recuperar la circulación espontánea.

D: Déficit Neurológico

En esta etapa se realiza la valoración del estado neurológico del paciente.

Si bien no pretende tener la minuciosidad del examen físico realizado por un neurólogo, con una evaluación de los aspectos que revisaremos, se pueden realizar intervenciones urgentes al paciente en estado crítico:

1. Describir estado neurológico y realizar examen de pupilas: simetría, tamaño y reactividad a la luz.
   Escala GCS (Glasgow): Es mejor describir cada punto de la escala de Glasgow (GCS) que usarla como escala dado que fue diseñada para describir el nivel de compromiso de pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico, aunque ya ha sido validada en otros escenarios.
2. Hemoglucotest (HGT): La hipoglicemia es una causa frecuente y fácilmente corregible de compromiso de conciencia, convulsiones y alteraciones neurológicas focales. Por su rapidez y disponibilidad, debe considerarse una pieza más de la evaluación primaria neurológica.
3. Otras: función motora, observar reflejos de tronco, pares craneanos, marcha desde que entra el paciente, consignar los reflejos corneales en caso de compromiso de conciencia cuantitativo, etc.

Intervenciones:

- Administración de glucosa en hipoglicemia.
- TAC de cerebro.
- Reversión de TACO (anticoagulante).
- Si hay signos herniación cerebral: hiperventilación, manitol o suero hipertónico.

E: Exposición

La E generalmente es la etapa olvidada de la evaluación primaria y si bien, en general, puede no ser la más importante, no hay que olvidarla porque puede entregar la clave diagnóstica.

En esta fase se inspecciona minuciosamente la piel del paciente, valorando la humedad, color, temperatura, olor, presencia de lesiones cutáneas, etc.

Intervenciones en esta etapa:

- Retirar la ropa mojada y abrigar en caso de hipotermia.
- Administrar antipiréticos.

Otro aspecto importante de tratar, que en algunos casos se hace dentro de los signos vitales, es el dolor.

Manejar el dolor limpia la historia clínica, nos ayuda a trabajar. Saber ocupar los analgésicos es parte de la evaluación primaria. También incluiremos dentro de la evaluación primaria el tratamiento de los vómitos, ya que es importante para que el paciente se sienta mejor, relate mejor su historia y pueda tomar otros medicamentos.
No se debe olvidar esto en la evaluación primaria por humanidad y porque nos va a ayudar en nuestro trabajo.

Estas son las etapas del clásico A B C D E que como profesionales de la salud tenemos que tener impreso en nuestro cerebro. En la siguiente tabla se puede observar un resumen de las intervenciones que se realizan en cada fase de la evaluación primaria.

Intervenciones durante la evaluación primaria	
a. Vía aérea y columna cervical	- Posicionar al paciente (tracción mandibular en caso de trauma). - Permeabilizar la vía aérea (cánula orofaríngea). - Inmovilización de columna cervical (collar rígido). - Retiro de cuerpos extraños. - Aspiración de secreciones. - Administración de oxígeno suplementario. - Intubación orotraqueal (con/sin sedación). - Vía aérea quirúrgica (cricotiroidotomía o traqueostomía).
b. Respiración	- Oxígenoterapia. - Descompresión torácica con aguja gruesa. - Pleurostomía. - Reversión de la intoxicación con opiáceos: uso de naloxona.

Intervenciones durante la evaluación primaria	
c. Circulación	- Vía venosa periférica, monitor cardíaco, ECG. - Administración de fluidos y hemoderivados. - Reversión de anticoagulación. - Manejo de bradi y taquiarritmias. - Pericardiocentesis.
d. Déficit neurológico	- Imágenes (TAC cerebro) de urgencia. - Administración solución glucosada (hipoglicemia). - Hiperventilación, administración de manitol o suero hipertónico (signos de herniación cerebral).
e. Exposición	- Desvestir, retirar ropa mojada o abrigar según corresponda. - Administrar antipiréticos. - Analgesia. - Antieméticos.

Fuente: Modificado de Revista Chilena de Medicina Intensiva. 2012; VOL 27(4): 237-244

Cada uno de estos puntos tenemos que manejarlos en detalle.

Ultrasonido

Cada día estará más en el enfrentamiento inicial, incluir en la evaluación primaria el ultrasonido.

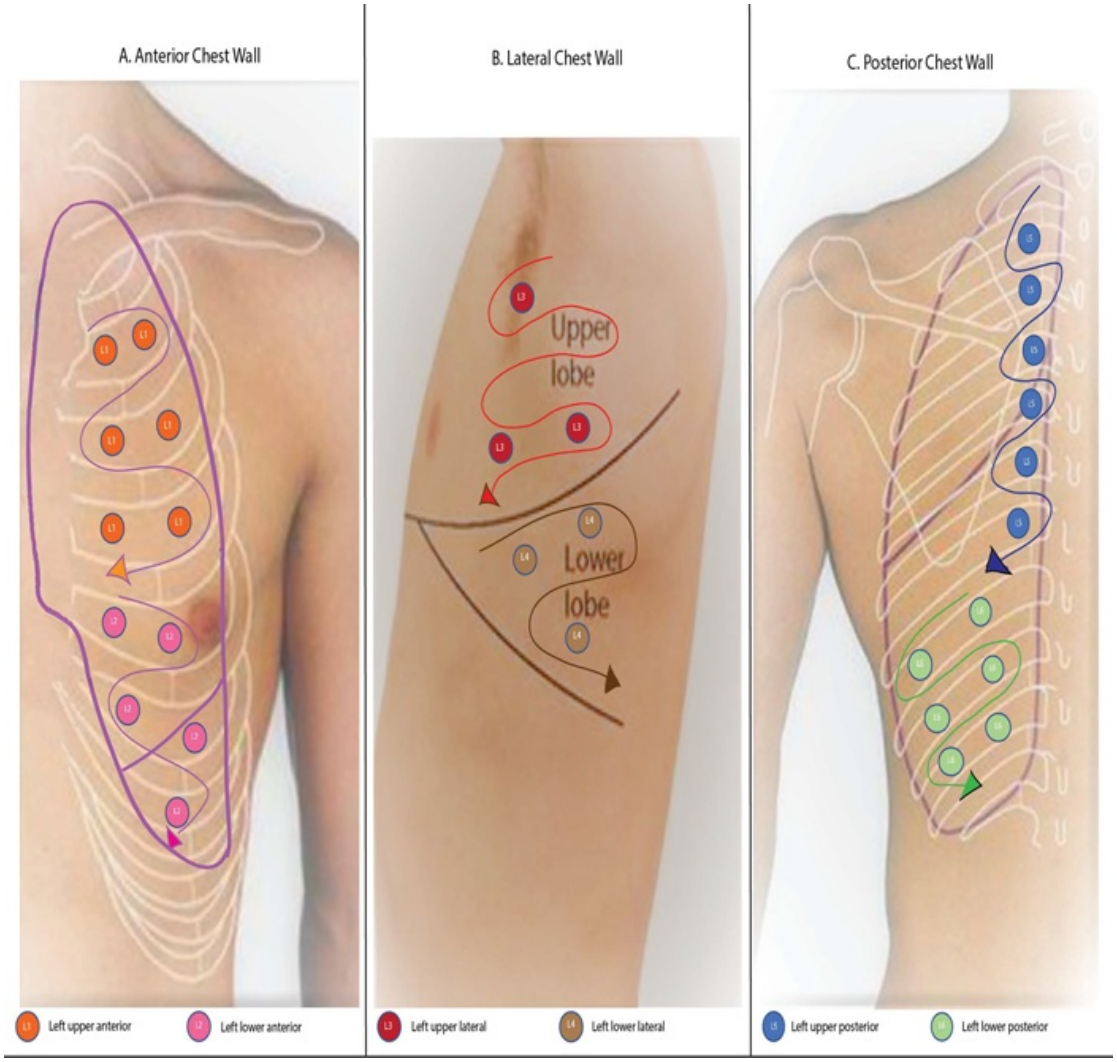
Se trata de una evaluación fisiopatológica no anatómica, para responder preguntas concretas y simples. Por ejemplo: el corazón está latiendo bien o mal.

Es un tema que se está estudiando, hay protocolos que se están haciendo extensivos en la urgencia:

1. Primero fue el E-FAST, utilizado en trauma abdominal, que también tiene sus orígenes en situaciones de guerra, para saber qué paciente tiene que ir de inmediato a pabellón.

2. Está el RUSH para examinar con el ecógrafo un paciente con shock indiferenciado para saber la causa.

3. El protocolo CLUE, aplicado en la evaluación de pacientes COVID-19 o sospechosos. En este se divide cada pulmón en 6 segmentos. Dos anteriores, dos laterales y dos posteriores. Se escanea cada uno de ellos por cada espacio intercostal de forma unidireccional y se determina el puntaje de cada segmento pulmonar.

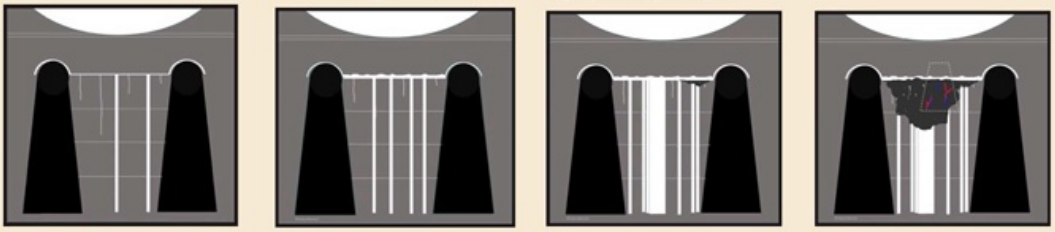


El puntaje va del 0 al 3, donde 0 es pulmón normal y el 3 es condensación pulmonar mayor de 1 cm, broncograma aéreo o aumento de la vasculatura pulmonar. Sumando el puntaje de cada segmento, obtenemos el score total que se clasifica por tramos junto al requerimiento de oxígeno y esto nos sugiere el destino del paciente: alta, seguimiento estrecho post alta, cama básica o unidad de paciente crítico.

CLUE PROTOCOL

COVID19 Lung Ultrasound in Emergency Department

Lung Ultrasound Scoring System (LUSS)



LUSS 0	LUSS 1	LUSS 2	LUSS 3
A lines, 1or2 B-lines, Smooth thin pleural line	>2 B-lines but discrete, Irregular/ thickened pleura	Confluent B-lines, subpleural consolidations (height <1cm)	Large consolidations (height >1cm) +/- air bronchogram +/- vascularity

CLUE protocol

Classification	Total LUSS Score from 12 zones	Clinician's decision to supplement oxygen?	Disposition from Emergency Department	
Normal	0	No	Home	
		Yes	Consider alternate cause & appropriate disposition	
Mild	1-5	No	Home + follow-up monitoring	
		Yes	Home with SPO_2 monitoring +/- Oxygen (or) Consider admission to ward	Involve Respiratory / ICU Physician
Moderate	>5 - 15	No	Home with SPO_2 monitoring +/- Oxygen (or) Consider admission to ward	Involve Respiratory / ICU Physician
		Yes	Admit to Ward/ Consider ICU	Involve Respiratory / ICU Physician
Severe	>15	No	Admit to Ward	Involve Respiratory / ICU Physician
		Yes	Admit to ICU	Involve Respiratory / ICU Physician

LUSS= Lung Ultrasound Scoring System, Ward = Respiratory or other appropiate ward, ICU = Intensive care unit, SPO_2 = Pulse Oximetry.

4. Se están estudiando cada día más protocolos para su aplicación en la Urgencia como los de dolor torácico, manejo de sepsis, paro cardiorrespiratorio, etc.

Estos protocolos desarrollados recientemente permiten al médico tomar decisiones rápidas, identificando condiciones clínicas que amenazan la vida, haciendo más expedito el manejo del paciente grave o potencialmente grave. Bajo este concepto, la incorporación de la ultrasonografía en la evaluación primaria podría ser razonable como parte del examen físico, particularmente dentro del componente circulatorio (C).

A continuación, te invitamos a revisar el siguiente cuadro del protocolo del RUSH, el que consta de tres fases, en las que se responden preguntas específicas acerca del funcionamiento del corazón, el volumen intravascular efectivo y el sistema circulatorio arterial y venoso.

Protocolo RUSH (rapid ultrasound in shock): Hallazgos ultrasonógraficos característicos en diferentes tipos de shock.

"The Pump"	Shock hipovolémico	Shock cardiogénico	Shock obstructivo	Shock distributivo
¿Tiene derrame pericárdico?	-	-	Derrame pericárdico. Signos de taponamiento cardíaco.	-
¿Cómo se contrae globalmente el ventrículo izquierdo?	Aumento de la contractilidad.	Disminución de la contractilidad.	Aumento de la contractilidad.	Aumento de la contractilidad (sepsis precoz). Disminución de la contractilidad (sepsis tardía).
¿Cuál es la relación VD/VI?	Cámaras disminuidas de tamaño.	Dilatación de las cavidades cardíacas.	Aumento de tamaño del VD.	-
"The Tank" Tamaño y colapsabilidad de la VCI.	VCI depletada.	VCI y yugulares distendidas.	VCI y yugulares distendidas.	VCI normal o depletada (sepsis precoz).
E- FAST y examen del parénquima pulmonar. -	Líquido libre intraperitoneal. Derrame pleural.	*Lung rockets* (síndrome intersticial) Líquido libre intraperitoneal (ascitis) Derrame pleural.	Ausencia de deslizamiento entre la pleura parietal y visceral pulmonar (neumotórax).	Líquido libre intraperitoneal o derrame pleural. (focos de la sepsis)
"The Pipes" Evaluación de la circulación arterial y venosa.	Aneurisma aorta abdominal Disección aórtica.	Normal.	TVP.	Normal.

"The Pump"	Shock hipovolémico	Shock cardiogénico	Shock obstructivo	Shock distributivo
Abreviaciones: VI: Ventrículo izquierdo; VD: Ventrículo derecho; VCI: Vena Cava Inferior; TVP: Trombosis venosa profunda.				

Fuente: Revista Chilena de Medicina Intensiva. 2012; VOL 27(4): 237-244.

Caso clínico

A continuación, te presentamos un caso clínico con un ejemplo de evaluación primaria, para una mejor comprensión de lo estudiado.

- Hombre 68 años
- Motivo de Consulta: Dolor abdominal + Síncope

Evaluación Primaria	
A	Vía Aérea permeable. Signos de trauma en cuero cabelludo (caída a nivel por síncope), dolor a la palpación línea media cervical. **ALTERADA** ⇒ Inmovilización con collar cervical.
B	Murmullo pulmonar (MP) + simétrico, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, sin uso musculatura accesoria. Sat 100% con FIO2 ambiental.
C	Presión Arterial 100/80 Frecuencia cardíaca: 100 por minuto. Llene capilar enlentecido. Durante la evaluación presenta episodio de vómitos con sangre. **ALTERADA** ⇒ Monitorización y Reanimación: vía venosa periférica, exámenes incluyendo Gases en sangre venosa (GSV) + lactato. Solicitud de hemoderivados para transfusión. Monitorización. ECG.
D	Vigil, orientado en tiempo y espacio, moviliza 4 extremidades. Hemoglucotest 125.
E	Cicatriz laparotomía media toracoabdominal. Tº36.5C.
Ultrasonido (U)	Aneurisma de la aorta abdominal (AAA), líquido libre intrabdominal.

Diagnóstico operativo:

Síncope de alto riesgo.

Plan:

- Revaluación seriada de las medidas de reanimación.
- Volumen- Transfusión.
- Imagen (Diagnóstico: fístula aorto-entérica).
- Cirugía Vascular - Pabellón.

Evaluación secundaria

Cuando está lista la evaluación primaria, nos podemos detener en la evaluación secundaria y continuar evaluando al paciente de la manera tradicional, como aprendimos en la Universidad, que es flexible según cada paciente y motivo de consulta, hablar de la historia clínica, antecedentes cardiovasculares en pacientes con dolor torácico, los medicamentos, etc.

Cuando ya tenemos más controlada la situación podemos ahondar más en quién es el paciente. Dentro de la evaluación secundaria siempre hay que conocer muy bien a poblaciones especiales como adulto mayor, inmunodeprimido y embarazadas, porque les tenemos que hacer otras preguntas e intrevenciones.

Con toda esta información el médico de urgencia debería hacer un diagnóstico sindromático.

Algunos ejemplos de **Motivos de consulta y Enfrentamiento sindromático** son:

- Dolor torácico: ECG (electrocardiograma).
- Compromiso de conciencia: HGT (hemoglucotest), Tratamiento Anticoagulante Oral (TACO), trauma supraclavicular.
- Síncope: HGT (hemoglucograma), ECG (electrocardiograma).

Puntos Principales

- Los servicios de urgencia son centros atención de alta complejidad médica, sin restricción de entrada de usuarios, donde ingresan pacientes que presentan motivos de consulta indiferenciados y en múltiples etapas de la enfermedad.
- Un concepto muy importante para el personal de la salud que trabaja en Urgencia es la patología tiempo dependiente que se refiere a enfermedades cuya evolución y pronóstico están determinados por su pesquisa y manejo oportuno.
- La evaluación primaria es la primera aproximación al paciente con patología aguda indiferenciada, entrega un método rápido, estructurado y sistematizado para manejar el escenario en un ambiente difícil de controlar.
- La evaluación primaria ayuda a identificar y priorizar pacientes con gravedad extrema o potencial gravedad, así como también minimizar todo lo posible el error al tomar decisiones, en un ambiente adverso con poca información.
- Se propone un orden sistemático para realizar la primera aproximación diagnóstica, la que separamos por letra solo por motivos didácticos: A: Vía aérea y columna cervical, B: Respiración, C: Circulación, D: Déficit Neurológico, E: Exposición.
- Es importante considerar que se puede alterar el orden de la evaluación, de hecho, la evaluación integral de cada aspecto es más relevante que cada elemento por separado.
- El Ultrasonido es una herramienta cada día más disponible con la que ampliamos nuestra evaluación primaria, pudiendo ver las alteraciones dinámicas que presenta el paciente.

Bibliografía Unidad 1

Referencias Bibliográficas

1. Departamento de estadísticas e información en salud (DEIS), Ministerio de Salud.

2. Revista Chilena de Medicina Intensiva. 2012; VOL 27(4): 237-244

3. Bernhard M, Becker TK, Nowe T, Mohorovicic M, Sikinger M, Brenner T, et al. Introduction of a treatment algorithm can improve the early management of emergency patients in the resuscitation room. Resuscitation 2007; 73: 362-73. Citado en Revista Chilena de Medicina Intensiva. 2012; VOL 27(4): 237-244.

4. Parks JK, Elliot AC, Gentilello LM, Chafi S. Systemic hypotension is a late marker of shock after trauma: a validation study of advanced trauma life support principles in a large national sample. Am J Surg 2006; 192: 727-31. Citado en Revista Chilena de Medicina Intensiva. 2012; VOL 27(4): 237-244.

5. Perera P1, Mailhot T, Riley D, Mandavia D. The RUSH exam: Rapid Ultrasound in SHock in the evaluation of the critically Ill. Emerg Med Clin North Am. 2010 Feb;28(1):29-56, vii. doi: 10.1016/j.emc.2009.09.010.

6. Manivel V, Lesnewski A, Shamim S, Carbonatto G, Govindan T. CLUE: COVID-19 Lung Ultrasound in Emergency Department [published online ahead of print, 2020 May 9]. *Emerg Med Australas*. 2020;10.1111/1742-6723.13546. doi:10.1111/1742-6723.13546.